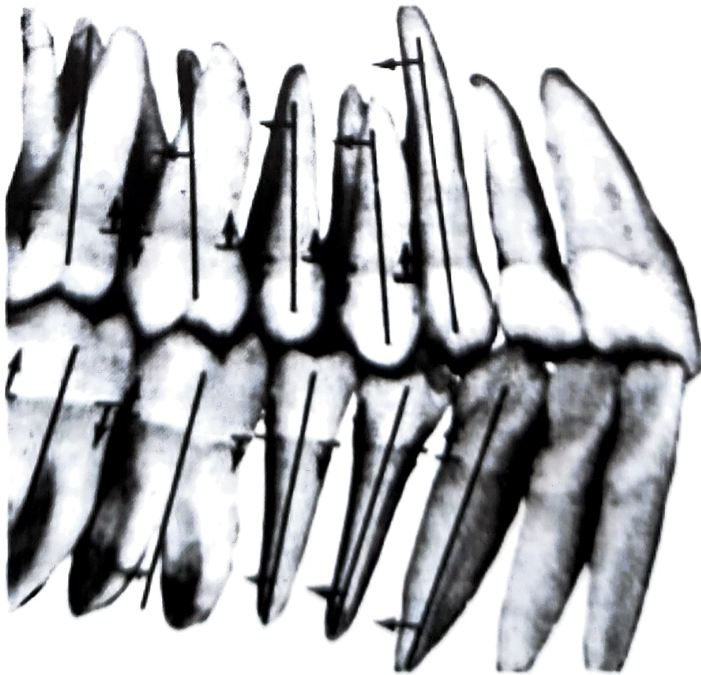


Phần thứ nhất
NHẬP MÔN



BÀI MỞ ĐẦU

MỤC TIÊU

1. *Phát biểu được định nghĩa môn giải phẫu răng.*
2. *Trình bày và thảo luận được vị trí và tầm quan trọng của môn giải phẫu răng trong chuyên ngành Răng Hàm Mặt (RHM) và các ngành khoa học khác.*
3. *Kể được tên các thành phần của hệ thống nhai.*
4. *Định nghĩa được cơ quan răng và vẽ hình để giải thích được cấu trúc của nó.*
5. *Trình bày được công thức răng (nha thức), kể được tên của từng răng, viết được ký hiệu răng.*

1. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA

1.1. Định nghĩa giải phẫu răng

Giải phẫu răng là một môn nha khoa cơ sở nghiên cứu về hình thái, cấu tạo của từng răng, tương quan giữa các răng trên cung răng và tương quan giữa hai cung răng.

Như vậy, giải phẫu răng là một môn khoa học, lấy răng và bộ răng làm đối tượng nghiên cứu. Trong Nha khoa, đối tượng cụ thể của giải phẫu răng là răng và bộ răng người. Trong các ngành khoa học khác (sinh học so sánh, sinh học tiến hóa, cổ sinh học, khảo cổ học, cổ nhân học, nhân học, dân tộc học, xã hội học...), răng và bộ răng (người và các động vật khác) cũng có vị trí nhất định, nhiều trường hợp là tư liệu nghiên cứu rất quan trọng, thậm chí là tư liệu duy nhất và có giá trị nhất của nghiên cứu.

Tri thức khoa học về giải phẫu răng bao gồm một hệ thống các khái niệm, phạm trù và quy luật. Tương tự như ở môn giải phẫu người, giải phẫu răng thường là môn học chuyên ngành đầu tiên mà sinh viên Nha khoa được làm quen. Hệ thống khái niệm mà giải phẫu răng cung cấp không những chỉ phục vụ cho bản thân việc nghiên cứu mô tả răng và bộ răng mà còn là những khái niệm cơ bản cho các môn khoa học và kỹ thuật thực hành khác. Do đặc điểm của bệnh lý và những thủ thuật trong nha khoa, các mô tả về hình thái luôn chiếm một vị trí quan trọng và vì thế, cần có một hệ thống thuật ngữ tương đối thống nhất. Giải phẫu răng, với tư cách là một môn nha khoa cơ sở, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống thuật ngữ chuyên ngành này. Các phạm trù và quy luật về giải phẫu răng là những vấn đề không những có ý nghĩa lý luận mà còn có giá trị ứng dụng rộng rãi trong thực hành điều trị, dự phòng. Về mặt phân loại sinh vật, con người là một động vật cấp cao và cao cấp nhất trong bậc thang tiến hóa. Giải phẫu răng cũng tuân theo những quy luật của giải phẫu học và của sinh học: giải phẫu răng đồng thời cũng là một môn thuộc sinh học người.

1.2. Hệ thống nhai

Hệ thống nhai là một tổng thể, một đơn vị chức năng, bao gồm: răng và nha chu, xương hàm, khớp thái dương hàm, cơ hàm, hệ thống môi - má - lưỡi, các tuyến nước bọt, hệ thống mạch máu và thần kinh nuôi dưỡng và chi phối các cơ quan đó.

Hệ thống nhai không chỉ đảm nhiệm chức năng nhai mà còn thực hiện hoặc tham gia thực hiện nhiều chức năng khác: bú, nuốt, nói...; hệ thống nhai đóng vai trò quan trọng trong đời sống (chức năng giao tiếp và biểu cảm), vì vậy, có tầm quan trọng đặc biệt đối với chất lượng cuộc sống, hoạt động xã hội, sức khỏe và hạnh phúc của con người.

Mục tiêu công việc của thầy thuốc nha khoa là tạo ra và mang lại sự lành mạnh và thoải mái cho hệ thống nhai của cộng đồng và mỗi cá nhân, qua đó, góp phần mang lại sức khỏe toàn diện cho con người, cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của ngành y tế là phòng chống dịch bệnh, nâng cao thể lực, cải thiện giống nòi và tăng tuổi thọ của toàn dân.

1.3. Cơ quan răng

Cơ quan răng bao gồm *răng* và *nha chu* (quanh răng), là đơn vị hình thái và chức năng của bộ răng (hình 1-4).

Răng là bộ phận trực tiếp nhai nghiền thức ăn, nha chu là bộ phận giữ và nâng đỡ răng, đồng thời là bộ phận nhận cảm, tiếp nhận và dẫn truyền lực nhai.

Răng chính danh gồm: men, ngà (mô cứng) và tủy (mô mềm).

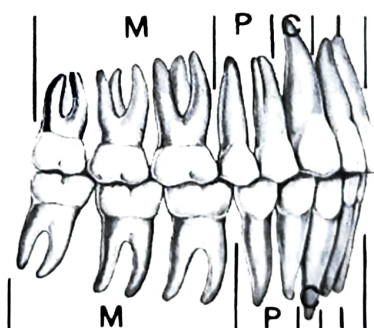
Nha chu gồm: xê măng, dây chằng, xương ổ răng, nướu.

Do xê măng bám chặt vào ngà chân răng và có nhiều bệnh lý chung với các mô cứng khác của răng (men, ngà), về mặt giải phẫu lâm sàng, xê măng là thành phần thường được mô tả cùng với răng.

Bộ răng là một thể thống nhất thuộc hệ thống nhai, tạo thành bởi sự sắp xếp có tổ chức của các cơ quan răng (hình 1-1).

Về mặt phôi thai học và mô học, răng nói riêng, cơ quan răng nói chung, có nhiều nguồn gốc.

- Men răng có nguồn gốc ngoại bì, là một sản phẩm của tế bào, khoáng hóa cao độ và cứng nhất cơ thể; thành phần hữu cơ là các protein của khuôn men.
- Ngà và xê măng là những mô khoáng hóa đặc biệt có nguồn gốc trung bì, trong đó thành phần khung sợi là collagen.
- Tủy có nguồn gốc trung mô của nhú răng.
- Dây chằng răng-xương ổ răng thuộc mô liên kết, là sản phẩm của túi răng.
- Nướu gồm biểu mô phủ và thành phần mô liên kết phụ thuộc.



- I: Răng cửa
- C: Răng nanh
- P: Răng cối nhỏ
- M: Răng cối lớn

Hình 1-1. Bộ răng vĩnh viễn, nửa hàm trên và dưới bên phải.

1.4. Tầm quan trọng của môn học giải phẫu răng

Giải phẫu răng là môn học cơ sở cho các môn nha khoa khác. Giải phẫu răng mô tả hình thái răng và bộ răng bình thường, làm cơ sở để nhận biết các biểu hiện bất thường và bệnh lý. Bằng việc cung cấp các kiến thức về hình thái và đặc điểm hình thái gắn với chức năng, *giải phẫu răng ngày nay không phải chỉ là môn học về những chi tiết giải phẫu mô tả đơn thuần, khô cứng mà còn là một trong những môn giúp người học bước đầu vận dụng kiến thức để quan sát các hoạt động chức năng của bộ răng*. Gắn hình thái với chức năng, gắn giải phẫu mô tả ở trạng thái tĩnh với mối quan hệ động chính là một phần quan trọng để giải phẫu răng, một mặt duy trì mối liên hệ với các môn nha khoa khác, mặt khác, giúp người học rèn luyện tư duy biện chứng rất cần thiết và có tác dụng lâu dài đối với công việc của người thầy thuốc răng miệng sau này. Có thể nói *Bác sĩ Răng Hàm Mặt mà không được trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành về giải phẫu răng thì không những không có ích mà còn có hại*.

1.5. Giải phẫu so sánh răng

Con người không phải là loài duy nhất có răng. So sánh bộ răng và hệ thống nhai của các động vật với nhau và với con người cho thấy xu hướng của sự tiến hóa và thấy được sự thích ứng của hệ thống nhai về hình thái và chức năng trong những điều kiện sống khác nhau. Sự tiến hóa của bộ răng người theo xu hướng giản hóa (tiến hóa thoái bộ).

1.6. Nhân học răng

So sánh hình thái và kích thước răng của các cộng đồng người cho thấy tính đa dạng của bộ răng loài người. Nhiều đặc trưng về hình thái răng là những đặc điểm có tính di truyền và được duy trì bền vững, ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện sống. Bằng việc nghiên cứu đặc điểm hình thái nhân học, bộ răng có khả năng cho phép phân loại loài người đến mức đại chủng, tiểu chủng và loại hình.

1.7. Cổ nha học

Cổ nha học nghiên cứu các răng người cổ, là một ngành quan trọng của khảo cổ học và cổ nhân học về con người và môi trường cổ. Vì răng là bộ phận thường tồn tại lâu dài nhất và nhiều khi là duy nhất trong lòng đất của các di cốt cổ, nghiên cứu về răng, bộ răng và xương hàm luôn có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt.

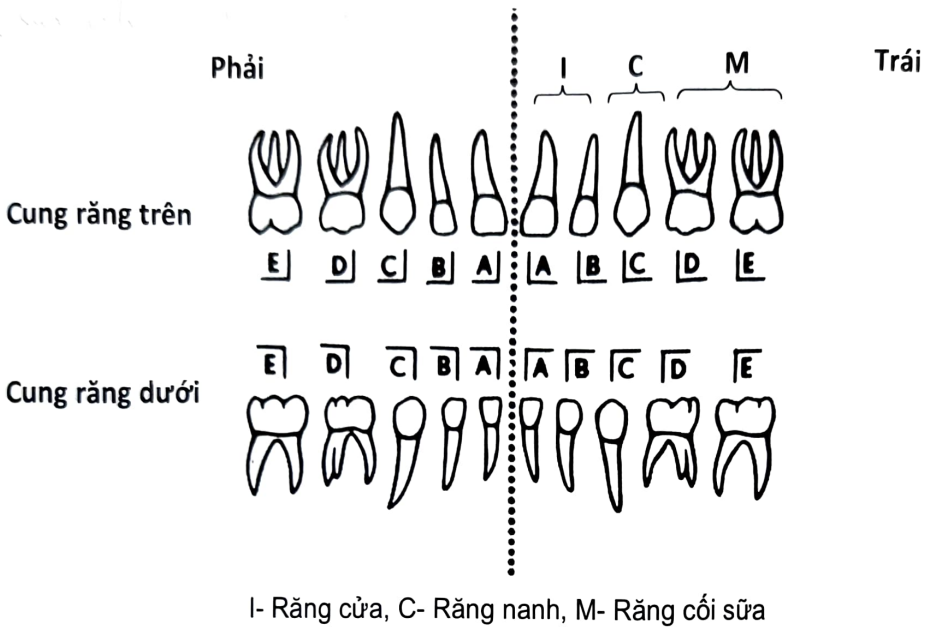
1.8. Khoa học pháp lý nha khoa (pháp nha học)

Là khoa học nghiên cứu răng và những dấu vết liên quan đến bộ răng phục vụ cho các điều tra về pháp lý; thí dụ: dựa vào dấu chứng để lại của bộ răng để truy tìm tội phạm hoặc nạn nhân của một vụ án. Người ta cũng dựa vào răng để nhận dạng một người về tuổi, giới, chủng tộc... trong các điều tra, giám định.

2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

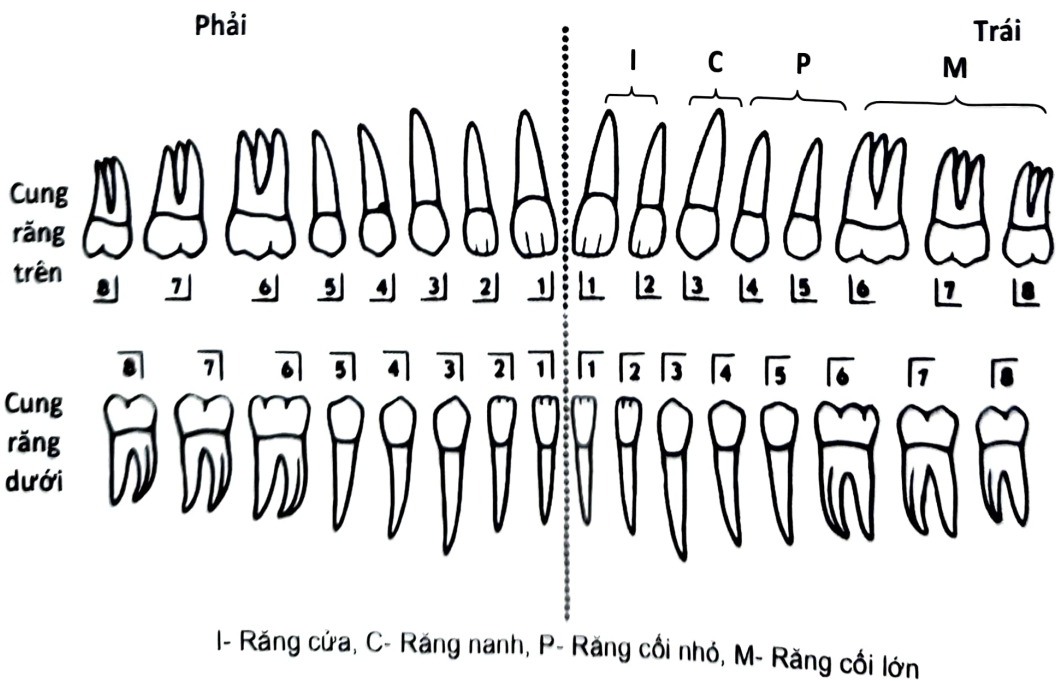
2.1. Răng sữa

Lúc mới sinh, trẻ không có răng trong miệng. Tuy vậy, phim tia X cho thấy có những phần căn tia X của mầm răng ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Trong thời kỳ nhũ nhi, thức ăn của trẻ lỏng hoặc sệt, do đó răng không giữ vai trò quan trọng trong ăn nhai. Bộ răng sữa (hình 1-2) là bộ răng tạm thời, bắt đầu mọc lúc 6 tháng tuổi, mọc đầy đủ lúc 24-36 tháng (xem chi tiết trong Phần thứ tư).



Hình 1-2. Bộ răng sữa.

2.2. Răng vĩnh viễn



Hình 1-3. Bộ răng vĩnh viễn.

Khi trẻ được khoảng 6 tuổi, các răng vĩnh viễn đầu tiên bắt đầu mọc, đó là răng “số 6” (răng 6 tuổi, răng cối lớn thứ nhất, răng cối lớn 1), sau đó các răng khác của bộ răng vĩnh viễn sẽ lần lượt mọc lên để thay thế các răng sữa. Bộ răng vĩnh viễn mọc đầy đủ ở tuổi 18-25 (hình 1-3).

Giai đoạn từ 6-7 tuổi đến 11-12 tuổi, trong miệng trẻ có hai loại răng cùng tồn tại, được gọi là *bộ răng* (hàm răng) *hỗn hợp* hay *bộ răng chuyển tiếp*.

2.3. Công thức răng (nha thức)

Công thức răng (nha thức) là một dãy chữ và số, dùng để biểu diễn số lượng răng của từng nhóm răng ở một bên hàm (gồm nửa hàm trên và nửa hàm dưới). Công thức răng thường được dùng phổ biến và có giá trị trong phân loại học động vật.

Công thức bộ răng sữa của người:

$$\text{Cửa } \frac{2}{2} \text{ Nanh } \frac{1}{1} \text{ Cối sữa } \frac{2}{2} = 10$$

(Nghĩa là có 10 răng sữa ở mỗi nửa hàm, bộ răng sữa đầy đủ có 20 răng).

Công thức bộ răng vĩnh viễn của người:

$$\text{Cửa } \frac{2}{2} \text{ Nanh } \frac{1}{1} \text{ Cối nhỏ } \frac{2}{2} \text{ Cối lớn } \frac{3}{3} = 16$$

(Nghĩa là có 16 răng vĩnh viễn ở mỗi nửa hàm, bộ răng vĩnh viễn đầy đủ có 32 răng).

Các răng cửa và răng nanh gọi chung là răng trước, các răng cối sữa hoặc các răng cối lớn và cối nhỏ gọi chung là răng sau.

2.4. Tên răng - sơ đồ răng - ký hiệu răng

2.4.1. Cách gọi tên

Bắt đầu từ đường giữa của hai cung răng đi về hai phía, răng được gọi tên tuần tự như sau:

Răng vĩnh viễn (ký hiệu bằng chữ số Ả Rập từ 1 đến 8):

Nhóm răng cửa: - Răng cửa giữa (răng số 1). /
- Răng cửa bên (răng số 2). /

Nhóm răng nanh: - Răng nanh (răng số 3). /

Nhóm răng cối nhỏ: - Răng cối nhỏ thứ nhất (cối nhỏ 1, răng số 4).
- Răng cối nhỏ thứ hai (cối nhỏ 2, răng số 5).

Nhóm răng cối lớn: - Răng cối lớn thứ nhất (cối lớn 1, răng số 6, răng 6 tuổi). /
- Răng cối lớn thứ hai (cối lớn 2, răng số 7, răng 12 tuổi). /
- Răng cối lớn thứ ba (răng số 8, răng khôn).

Răng sữa (ký hiệu bằng chữ cái từ A đến E hay chữ số La Mã từ I đến V).

Bộ răng sữa không có nhóm răng cối nhỏ.

Nhóm răng cửa sữa: - Răng *cửa giữa sữa* (răng A hay răng I).
 - Răng *cửa bên sữa* (răng B hay răng II).

Nhóm răng nanh sữa: - Răng *nanh sữa* (răng C hay răng III)

Nhóm răng cối sữa: - Răng *cối sữa thứ nhất* (*cối sữa 1, răng D hay răng IV*).
 - Răng *cối sữa thứ hai* (*cối sữa 2, răng E hay răng V*).

(Cách gọi tên “răng hàm” thay cho “răng cối” cũng khá phổ biến, nhưng dùng từ “cối” vừa sát nghĩa hơn, vừa đỡ gây nhầm lẫn trong các tập hợp từ có đi kèm với từ “hàm” trong “xương hàm, hàm trên, hàm dưới”...).

Tùy vị trí của răng trên cung răng, thuộc hàm trên hay hàm dưới, bên phải hay bên trái, răng được gọi tên đầy đủ bằng cách thêm tên các phần tư hàm đó hay các góc phần tư vào tên răng.

Ví dụ: Răng cối lớn 1 hàm trên bên phải.

Răng cối nhỏ 2 hàm dưới bên trái.

Răng cửa giữa sữa hàm trên bên phải.

Răng nanh sữa hàm dưới bên phải.

Ngoài ra, răng có thể được gọi tên hoặc ký hiệu theo nhiều cách khác nhưng không phổ biến. (Trên thực tế, cách nói và viết “răng cối lớn thứ nhất hàm trên bên phải” thường được giản hóa thành “răng cối lớn 1 trên phải” cũng được chấp nhận rộng rãi và thường được sử dụng trong sách này).

2.4.2. Sơ đồ răng *

Là sơ đồ biểu diễn từng răng theo vị trí trên các phần tư hàm của hai hàm. Sơ đồ răng cũng có thể là hình vẽ cung răng hoặc các mặt răng đơn giản hóa dùng trong mô tả, chẩn đoán, điều trị...

Răng vĩnh viễn

Trên phải (1)	Trên trái (2)
8 7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7 8
Dưới phải (4)	Dưới trái (3)

Răng sữa

V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V	E	D	C	B	A	A	B	C	D	E
V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V	E	D	C	B	A	A	B	C	D	E
(5)					(6)														
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5										
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5										
(8)					(7)														

2.4.3. Ký hiệu răng

Trong thực hành cũng như trong các văn bản (bệnh án, các báo cáo thống kê hoặc văn bản khoa học) để ghi răng, người ta thường sử dụng các ký hiệu:

Theo Palmer, răng được ký hiệu theo các chữ số ký hiệu răng, cùng với ký hiệu góc phần tư.

Ví dụ: Răng cối lớn 1 hàm trên bên phải được ký hiệu 6┐.

Răng cối nhỏ 2 hàm dưới bên trái được ký hiệu └5.

Răng nanh sữa hàm trên bên phải được ký hiệu C ┐ hay III┐.

Năm 1970, Liên đoàn Nha khoa Thế giới họp tại Bucarest (Rumani) đã đề nghị thống nhất sử dụng hệ thống ký hiệu răng gồm hai chữ số, răng được ký hiệu theo các mã số các phần tư hàm và chữ số ký hiệu răng.

Các phần tư hàm hay các góc phần tư được đánh số từ 1 đến 4 đối với răng vĩnh viễn và từ 5 đến 8 cho răng sữa (theo chiều kim đồng hồ từ góc trên phải).

Răng vĩnh viễn

1	2	Phần tư hàm trên bên phải	: phần hàm 1, thay cho ký hiệu ┐
4	3	Phần tư hàm trên bên trái	: phần hàm 2, thay cho ký hiệu └
		Phần tư hàm dưới bên trái	: phần hàm 3, thay cho ký hiệu ┌
		Phần tư hàm dưới bên phải	: phần hàm 4, thay cho ký hiệu ┘

Răng sữa

1	2	Phần tư hàm trên bên phải	: phần hàm 5, thay cho ký hiệu ┐
4	3	Phần tư hàm trên bên trái	: phần hàm 6, thay cho ký hiệu └
		Phần tư hàm dưới bên trái	: phần hàm 7, thay cho ký hiệu ┌
		Phần tư hàm dưới bên phải	: phần hàm 8, thay cho ký hiệu ┘

Ví dụ:

Răng cối lớn 1 hàm trên bên phải được ký hiệu 16 (đọc là “một sáu”, không đọc là “mười sáu”).

Răng cối nhỏ 2 hàm dưới bên trái được ký hiệu 35 (đọc là “ba năm” không đọc là “ba mươi lăm”).

Răng cửa giữa sữa hàm trên bên phải được ký hiệu 51 (đọc là “năm một” không đọc là “năm mươi mốt”).

Răng nanh sữa hàm dưới bên phải được ký hiệu là 83 (đọc là “tám ba” không đọc là “tám mươi ba”).

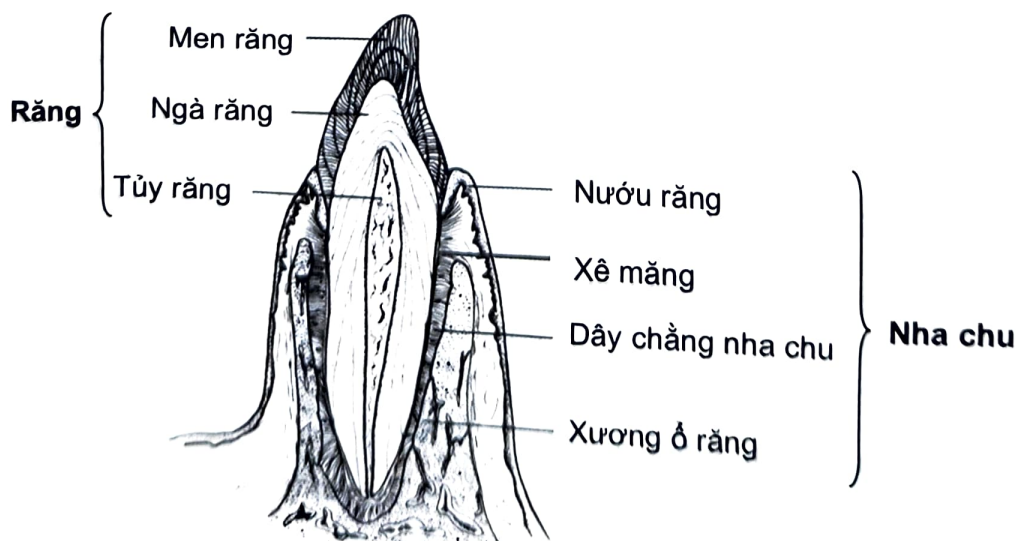
Theo ADA (Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ) ký hiệu răng còn có thể được định danh theo thứ tự từ 1 đến 32 (răng số 1 là răng cối lớn 3 trên phải, răng số 32 là răng cối lớn 3 dưới phải theo chiều kim đồng hồ). Tuy vậy, cách này không phổ biến ở các nước khác trên thế giới.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

3. SƠ LƯỢC CẤU TRÚC CỦA RĂNG

3.1. Các phần của răng

Mỗi răng có phần *thân răng* và *chân răng*. Giữa chân răng và thân răng là đường *cổ răng* (cổ răng giải phẫu), là một đường cong, còn gọi là *đường nối men-xê măng*. Thân răng được bao bọc bởi men răng, chân răng được xê măng bao phủ (hình 1-4).



Hình 1-4. Cơ quan răng.

Nướu răng viền xung quanh cổ răng tạo thành một bờ, gọi là *cổ răng sinh lý*. Phần răng thấy được trong miệng là *thân răng lâm sàng*. Cổ răng sinh lý thay đổi tùy theo nơi bám và bờ của *nướu viền*, khi tuổi càng cao thì nơi bám này càng có khuynh hướng di chuyển dần về phía chóp răng. Nhiều trường hợp bệnh lý, nướu răng có thể bị sưng hoặc trụt, làm thân răng (lâm sàng) bị ngắn lại hoặc dài ra (hình 1-5).



Cổ răng sinh lý
Cổ răng giải phẫu

Hình 1-5. Cổ răng giải phẫu và cổ răng sinh lý.

3.2. Cấu tạo của răng

Bao gồm: men răng, ngà răng (mô cứng) và tủy răng (mô mềm) (hình 1-4).

3.2.1. Men răng

Men răng phủ mặt ngoài ngà thân răng, có nguồn gốc từ ngoại bì, là mô cứng nhất trong cơ thể, có tỷ lệ chất vô cơ cao (96%).

Hình dáng và bề dày của men được xác định từ trước khi răng mọc ra, trong đời sống, men răng không có sự bồi đắp thêm mà chỉ mòn dần theo tuổi, nhưng có sự trao đổi về vật lý và hóa học với môi trường miệng.

3.2.2. Ngà răng

Có nguồn gốc từ trung bì, kém cứng hơn men, chứa tỷ lệ chất vô cơ thấp hơn men (75%). Trong ngà có nhiều ống ngà, chứa đuôi bào tương của nguyên bào ngà.

Bề dày ngà răng thay đổi trong đời sống do hoạt động của nguyên bào ngà. Ngà răng ngày càng dày theo hướng về phía hốc tủy răng, làm hẹp dần hốc tủy.

3.2.3. Tủy răng

Là mô liên kết mềm, nằm trong *hốc tủy* gồm *tủy chân* và *tủy thân*. Tủy răng trong *buồng tủy* gọi là *tủy thân*, *tủy buồng*, tủy răng trong *ống tủy* gọi là *tủy chân*. Các nguyên bào ngà nằm sát vách hốc tủy.

Tủy răng có nhiệm vụ duy trì sự sống của răng, cụ thể là sự sống của nguyên bào ngà và tạo *ngà thứ cấp*, nhận cảm giác của răng. Trong tủy răng có chứa nhiều mạch máu, mạch bạch huyết và đầu tận cùng thần kinh.

4. BỘ PHẬN NÂNG ĐỖ RĂNG (NHA CHU, QUANH RĂNG)

Bao gồm: xương ổ răng, xê măng, dây chằng nha chu và nướu (lợi) răng (hình 1-4).

4.1. Xương ổ răng

Là mô xương xốp, bên ngoài được bao bọc bằng màng xương, nơi nướu răng bám vào. Xương ổ răng tạo thành một huyết, có hình dáng và kích thước phù hợp với chân răng.

Bề mặt ổ răng, nơi đối diện với chân răng, là mô xương đặc biệt và có nhiều lỗ thủng để cho các mạch máu và dây thần kinh từ xương xuyên qua để nuôi dây chằng nha chu, gọi là *xương ổ chính danh* hay lá sàng. Trên hình ảnh tia X, phần xương ổ chính danh trông cân tia hơn, gọi là lá cứng.

Nền xương ổ không phân biệt được với xương hàm. Chiều cao xương ổ răng thay đổi theo tuổi và tùy theo sự lành mạnh hay bệnh lý của mô nha chu. Khi răng không còn trên xương hàm thì xương ổ răng và các thành phần của nha chu cũng bị tiêu dần đi.

4.2. Xê măng

Là mô cứng đặc biệt, hình thành cùng với sự hình thành chân răng, phủ mặt ngoài ngà chân răng.

Xê măng được bồi đắp thêm ở phía chóp chủ yếu để bù trừ sự mòn mặt nhai, được coi là hiện tượng mọc răng suốt đời. Xê măng cũng có thể tiêu hoặc quá sản trong một số trường hợp bất thường hay bệnh lý.

4.3. Dây chằng nha chu

Là những bó sợi liên kết, dày khoảng 0,25 mm, một đầu bám vào xê măng, còn đầu kia bám vào xương ổ chính danh. Cả xê măng, dây chằng nha chu và xương ổ chính danh đều có nguồn gốc từ túi răng chính danh.

Dây chằng nha chu có nhiệm vụ giữ cho răng gắn vào xương ổ răng và đồng thời có chức năng làm vật đệm, làm cho mỗi răng có sự xô dịch nhẹ độc lập với nhau trong khi ăn nhai, giúp lưu thông máu, truyền cảm giác áp lực và truyền lực để tránh tác dụng có hại của lực nhai đối với răng và nha chu.

4.4. Nướu răng

Là phần niêm mạc miệng phủ lên xương ổ răng (nướu dính) và cổ răng (nướu rời).

5. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP GIẢI PHẪU RĂNG

5.1. Lý thuyết

Tương tự như khi học giải phẫu học nói chung, việc học tập giải phẫu răng phải tuân theo các nguyên tắc trực quan kết hợp với vận dụng tưởng tượng, liên hệ và suy luận.

** Thực quan:*

Phải luôn luôn chú ý đối chiếu các mô tả trong bài giảng với việc quan sát răng trên miệng bản thân và người xung quanh, quan sát răng khô, mẫu hàm, mô hình, tranh vẽ. Khi học về hình thái, cấu trúc buồng tủy, ống tủy, phải quan sát các mặt cắt trên răng khô, hình ảnh phim tia X.

** Tưởng tượng, liên hệ và suy luận:*

Phải liên hệ được những quy luật hình thái, các khái niệm và thuật ngữ với hình thái cấu trúc từng răng, với hình thái cấu trúc chung của nhóm. So sánh cung răng trên với cung răng dưới và đối chiếu với các quy luật chung.

Lưu ý tập thói quen tưởng tượng về mối tương quan giữa các răng trên cung răng, mối tương quan giữa hai cung răng, giữa răng và các thành phần khác của hệ thống nhai.

Liên hệ được mối quan hệ giữa hình thái cấu trúc với chức năng ở răng người cũng như răng các động vật khác trong giải phẫu so sánh răng.

5.2. Thực hành

Thực hành giải phẫu răng là một phần quan trọng giúp tái hiện, củng cố những chi tiết đã học trong lý thuyết. Thực hành giải phẫu răng thường là môn thực hành nha khoa đầu tiên của sinh viên RHM, giúp *rèn luyện tính kiên nhẫn, cẩn cù, tỉ mỉ, chính xác* bên cạnh những đòi hỏi về *kỹ thuật thực hiện bản vẽ hoặc điêu khắc*. Phần thực hành giải phẫu răng (vẽ và điêu khắc các răng bằng thạch cao, bằng sáp) cũng có liên hệ trực tiếp tới thực hành về cắn khớp. Đây cũng là bước đầu quan trọng cho việc rèn luyện các kỹ năng tâm thần vận động, khả năng nhận xét và lặp lại hình ảnh trên mặt phẳng và hình khối trong không gian. Hình vẽ và răng được điêu khắc đúng cũng giúp rèn luyện *óc thẩm mỹ* và một số *kỹ năng đồ họa, tạo hình*, rất cần thiết trong các ứng dụng nghề nghiệp sau này của bác sĩ răng hàm mặt cũng như các đối tượng khác (điều dưỡng nha khoa, kỹ thuật viên phục hình răng...) được đào tạo cho ngành RHM.

THUẬT NGỮ

MỤC TIÊU

1. Định nghĩa được các thuật ngữ giải phẫu răng.
2. Chỉ được các chi tiết giải phẫu trên răng bằng các thuật ngữ tương ứng.
3. Định hướng được các mặt của một răng trong miệng hay trên mô hình.

1. CÁC THUẬT NGỮ ĐỊNH HƯỚNG

* Đường giữa:

Là một đường tưởng tượng thẳng đứng đi qua giữa cơ thể, chia cơ thể thành hai phần tương đối đối xứng.

* Phía gần:

Là phía gần đường giữa hoặc là phía hướng ra phía trước của răng sau.

* Phía xa:

Là phía ngược lại với phía gần hoặc là phía hướng về phía sau của răng sau.

* Phía ngoài:

Là phía hướng về hành lang (tiền đình miệng), là *phía môi* của răng trước và *phía má* của răng sau.

* Phía trong: (còn gọi là phía lưỡi)

Là phía hướng về khoang miệng chính thức, đối với các răng hàm trên, còn được gọi là *phía khẩu cái* (hình 1-6).

* Trục răng:

Là một đường tưởng tượng qua trung tâm của một răng theo trục chân răng. Ở các răng trước, người ta còn phân biệt trục chân răng và trục thân răng (hai trục này có thể không trùng nhau).

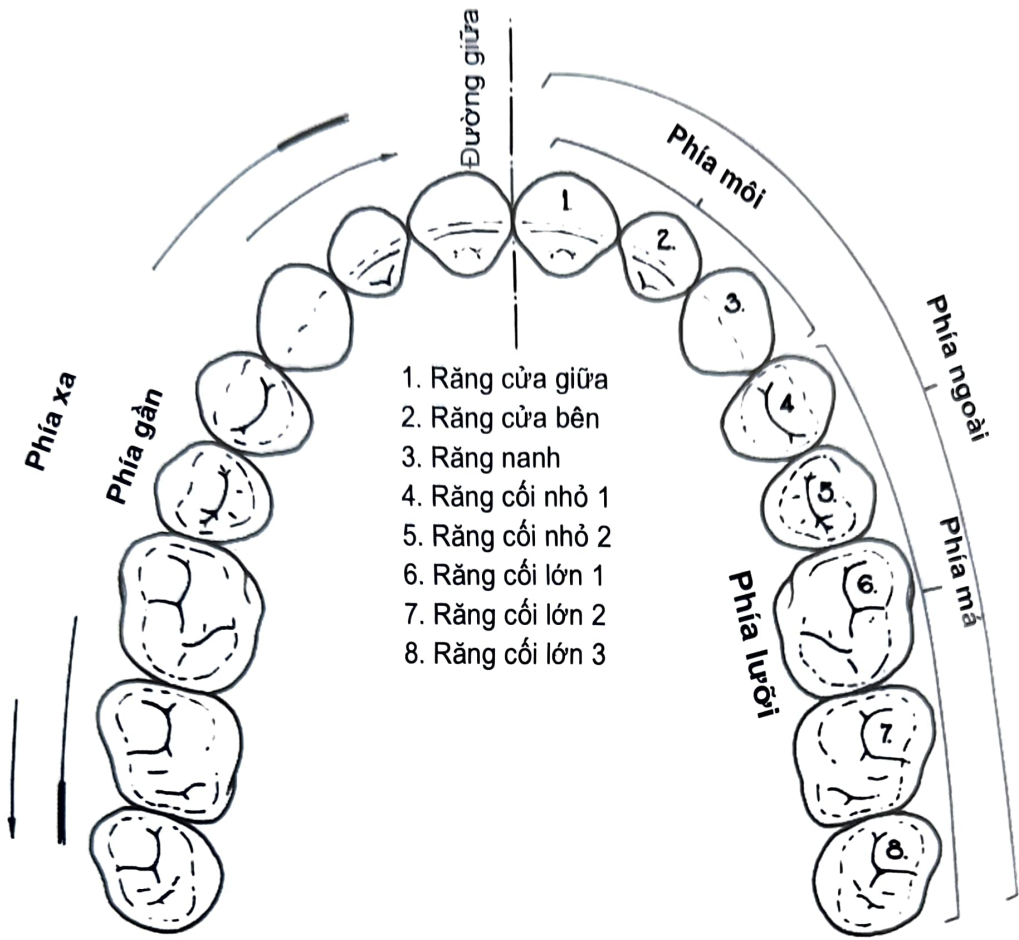
* Ngoài ra, một số thuật ngữ định hướng khác cũng được dùng rất phổ biến: *phía nhai*, *phía nướu*, *phía chóp*...

2. CÁC THUẬT NGỮ GIẢI PHẪU

2.1. Thân răng

2.1.1. Các mặt, cạnh, góc của thân răng (hình 1-7)

* *Mặt ngoài*: mặt hướng về phía ngoài tức là hướng về phía môi (*mặt môi*) của răng trước hay hướng về phía má (*mặt má*) của răng sau.



Hình 1-6. Tên răng và các thuật ngữ định hướng.

* **Mặt trong:** mặt hướng về phía trong tức là hướng về phía lưỡi (*mặt lưỡi*). Riêng đối với răng hàm trên, còn gọi là *mặt khẩu cái*.

* **Mặt gần:** mặt hướng về phía đường giữa của răng trước hay hướng về phía trước của răng sau.

* **Mặt xa:** mặt hướng về phía xa đường giữa của răng trước hay hướng về phía sau của răng sau.

* **Mặt bên:** là các mặt của một răng hướng về các răng kế cận trên cùng một cung răng. Cả mặt gần và mặt xa được gọi chung là mặt bên.

* **Mặt chức năng:** là mặt hướng về cung răng đối diện, là *rìa cắn* của răng trước và *mặt nhai* của răng sau.

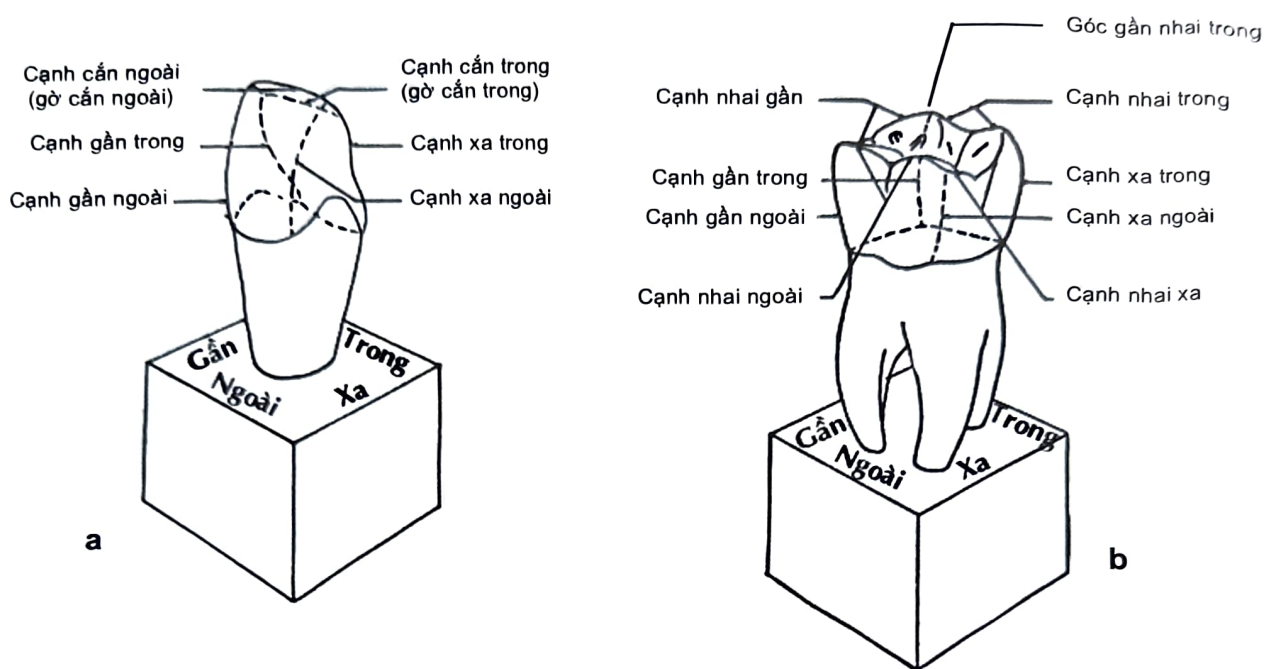
* **Cạnh:** là góc nhị diện tạo bởi sự gặp nhau của hai mặt.

Ví dụ: *cạnh nhai ngoài*, *cạnh nhai trong*...

* **Cạnh chuyển tiếp:** là cạnh giữa mặt ngoài hoặc mặt trong với mặt gần hoặc mặt xa.

* **Góc**: là một điểm trên một cạnh giữa hai mặt, giữa một mặt và một cạnh hay là nơi gặp nhau của ba mặt.

Ví dụ: góc gần nhai ngoài, góc gần nhai trong...



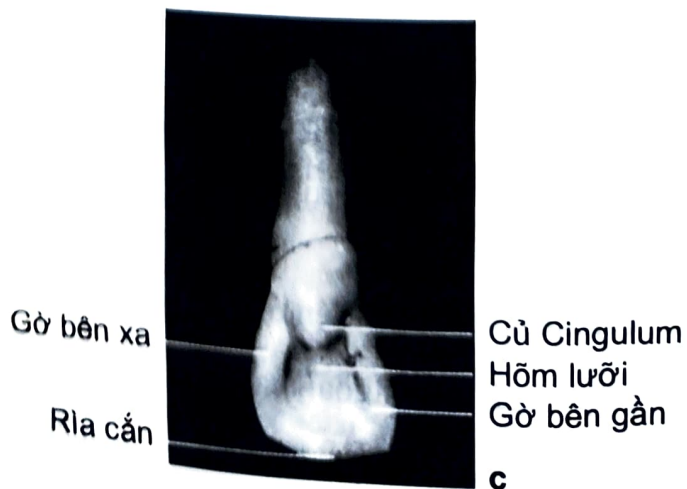
Hình 1-7. Các cạnh, các góc của thân răng.

a. Răng cửa b. Răng cối lớn



Hình 1-8. Các múi và chi tiết lồi.

a. Răng cối lớn 1 dưới phải.
b. Răng cối lớn 1 trên phải.
c. Răng cửa bên trên.



2.1.2. Các chi tiết lồi

* Múi (mù):

Là phần nhô lên ở mặt nhai thân răng, làm cho mặt nhai bị chia thành nhiều phần. Các múi được ngăn cách nhau bởi *rãnh chính*. Múi được gọi tên theo vị trí của nó (hình 1-8).

Ví dụ: múi gần ngoài, múi xa ngoài...

* Cú:

Là phần nhô lên ở nơi nào đó trên thân răng, thường nhỏ hơn múi, hình thành do men răng phát triển quá mức. Chúng có nhiều biến thể (lớn hơn, nhỏ hơn hay không có) từ dạng điển hình (hình 1-8b).

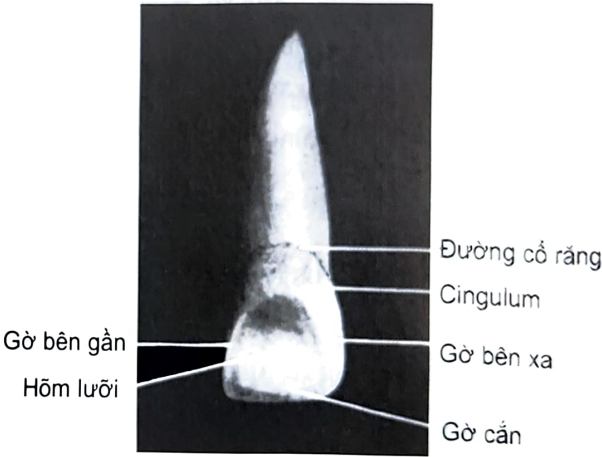
* *Cingulum* (trước đây, một số tài liệu gọi *Cingulum* là “gót răng”)⁽¹⁾

Là thùy phía lưỡi của răng trước, tạo nên phần ba nướu ở mặt trong các răng này, *cingulum* cong lồi theo chiều nhai nướu lẫn chiều gần xa (hình 1-9).

* Gờ:

Là đường nếp men tạo thành đường nổi trên mặt răng, gờ được đặt tên theo vị trí hoặc hình dáng gồm có những dạng sau:

Gờ bên: là những gờ men tạo thành bờ gần và bờ xa của mặt nhai các răng sau hoặc các bờ gần và bờ xa của mặt trong các răng trước (hình 1-9, 1-10, 1-11).



Hình 1-9. Mặt trong răng cửa giữa (hàm trên bên phải).



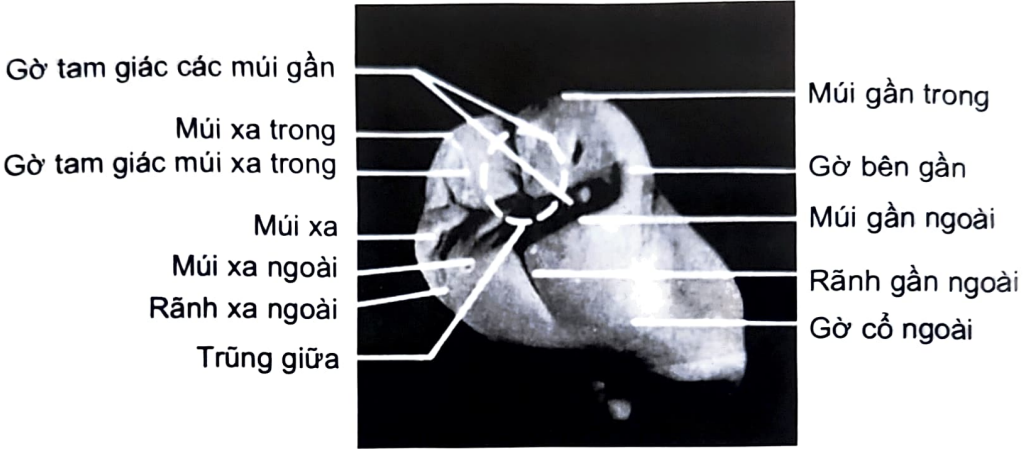
Hình 1-10. Răng cối lớn 1 trên phải (các gờ, rãnh, trũng, múi).

⁽¹⁾ Về thuật ngữ “gót răng”, xin xem bài mở đầu về Giải phẫu so sánh răng (chương 1, phần 5). *Cingulum* có thể gọi là “đai cổ” hay “lõi cổ răng”.

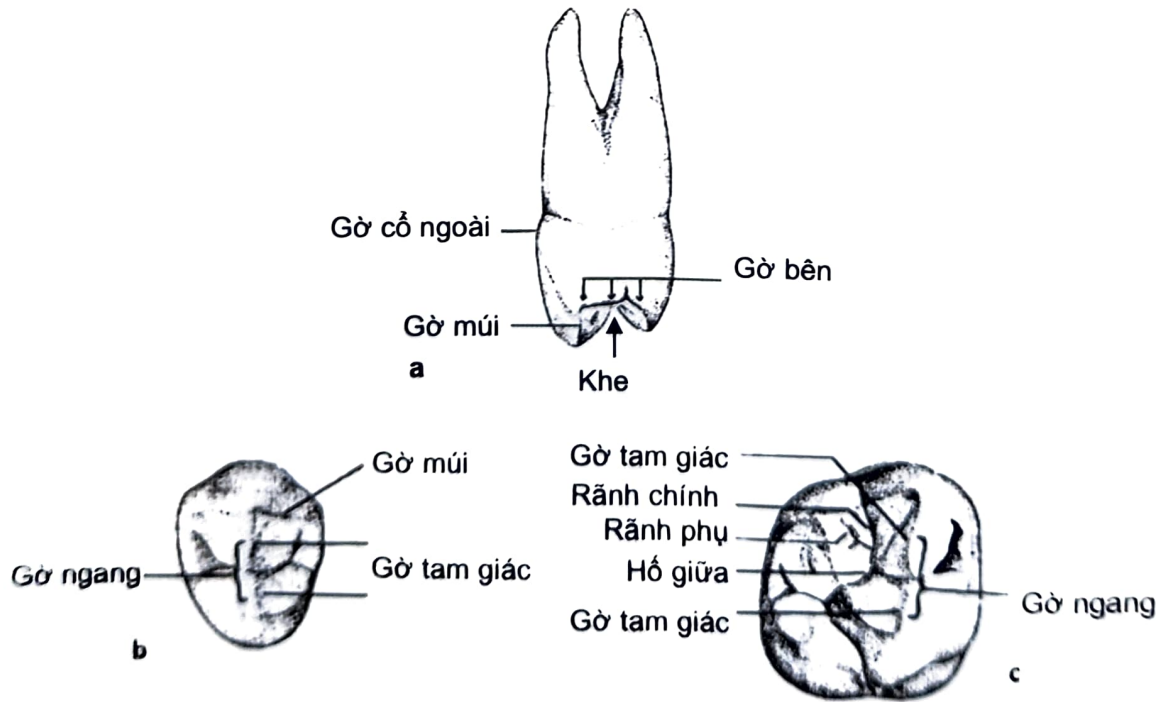
Gờ tam giác: là những gờ chạy từ đỉnh mũi về phía trung tâm mặt nhai. Chúng được gọi là gờ tam giác vì thiết diện của chúng có hình tam giác, mỗi mũi có một gờ tam giác và được gọi tên theo tên của mũi (hình 1-11, 1-12b, c).

Gờ mũi: là những gờ chạy từ đỉnh mũi theo hướng gần xa. Các gờ mũi tạo thành bờ ngoài và bờ trong của mặt nhai các răng sau (hình 1-12b, c).

Gờ cắn (rìa cắn): là phần rìa cắt của một răng cửa mới mọc. Sau một thời gian, gờ cắn bị mòn, hình thành gờ cắn ngoài và gờ cắn trong (hình 1-7a, 1-9).

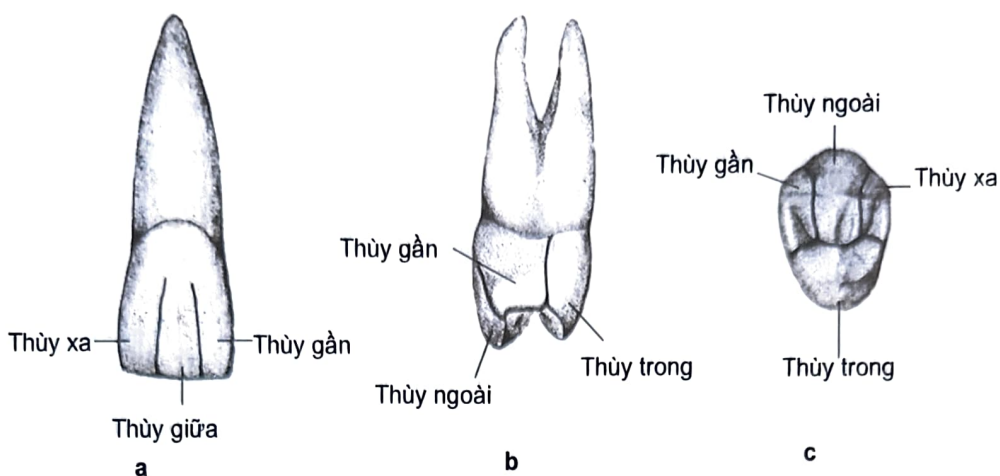


Hình 1-11. Răng cối lớn 1 dưới phải (các gờ, rãnh, trũng, mũi).



Hình 1-12. Các chi tiết giải phẫu.

- a. Răng cối nhỏ 1 trên phải nhìn từ phía gần.
- b. Răng cối nhỏ 1 trên phải nhìn từ phía nhai.
- c. Răng cối lớn 1 trên phải nhìn từ phía nhai.



Hình 1-13. Các thùy.

- a. Răng cửa giữa trên phải nhìn từ phía ngoài.
- b. Răng cối nhỏ 1 trên phải nhìn từ phía gần.
- c. Răng cối nhỏ 1 trên phải nhìn từ phía nhai.

Gờ chéo: là một gờ chạy chéo trên mặt nhai của các răng cối lớn trên, nó được tạo thành bởi sự ít nhiều liên tục của hai gờ tam giác của múi xa ngoài và múi gần trong (hình 1-10).

Gờ ngang: tạo bởi hai gờ tam giác của múi ngoài và múi trong ít nhiều liên tục với nhau, gờ ngang băng ngang qua mặt nhai của một răng sau (hình 1-11, 1-12b, c).

*** Thùy:**

Là đơn vị cấu tạo nguyên thủy trong sự phát triển thân răng trong quá trình khoáng hóa, được hình thành và phát triển từ những trung tâm khoáng hóa khác nhau (tương tự múi) (hình 1-13).

*** Nụ:**

Là những lõi hình tròn hay hình nón ở rìa cắn của một răng cửa mới mọc, có bao nhiêu nụ thì có bấy nhiêu thùy.

Ví dụ: răng cửa giữa hàm trên mới mọc thường có ba thùy: thùy gần, thùy giữa, thùy xa, phân cách nhau bởi rãnh gần và rãnh xa.

2.1.3. Các chi tiết lõm

*** Trũng (hõm):**

Là nơi được tạo thành bởi ba sườn nghiêng có liên hệ với nhau của cùng một răng, là nơi lõm xuống khá rộng trên mặt răng, gồm những dạng sau:

Hõm lưỡi: là hõm ở mặt lưỡi của răng cửa và răng nanh (hình 1-9).

Trùng giữa: là trùng ở trung tâm mặt nhai của một răng cối lớn, được tạo thành bởi ba sườn nghiêng nội phần của ba múi hoặc bốn múi (hình 1-10, 1-11).

Trùng tam giác: là trùng ở sát gờ bên của các răng cối nhỏ và răng cối lớn (*trùng tam giác gần* và *trùng tam giác xa*), được tạo thành bởi sườn nhai của gờ bên và hai nội phần của múi ngoài và múi trong sát với gờ bên đó (hình 1-10). Trùng tam giác cũng có thể gặp ở mặt trong các răng cửa trên nếu các gờ gần, gờ xa và cingulum nổi đủ rõ.

*** Hố:**

Là một trùng nhỏ và sâu, được tạo thành do sự gặp nhau của các rãnh chính hay là nơi kết thúc của một rãnh chính: *hố giữa* ở đáy trùng giữa, *hố gần* ở đáy trùng tam giác gần, *hố ngoài* ở nơi kết thúc của rãnh ngoài... (hình 1-12c).

*** Khe:**

Là phần lõm trên mặt răng, được tạo bởi sườn nghiêng của hai phần lồi kề nhau của thân răng, có thể gặp khe giữa hai múi, khe giữa múi và gờ..., ở đáy khe là một rãnh (hình 1-12a).

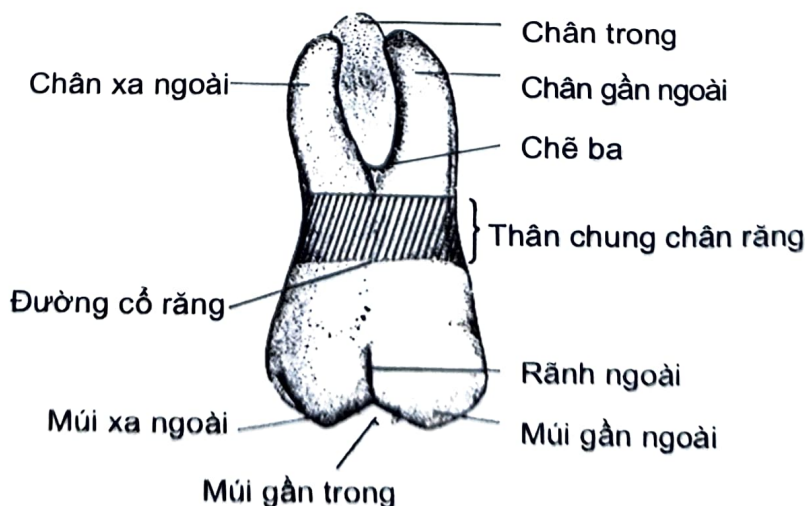
*** Rãnh:** ở đáy của khe, có hai dạng chính:

Rãnh chính: tạo nên ranh giới giữa các múi và các thùy.

Rãnh phụ: là những rãnh kém rõ hơn trên mặt răng, nó làm cho mặt răng phức tạp hơn nhưng không phân chia mặt răng thành các múi và các thùy (hình 1-10).

2.2. Chân răng

2.2.1. Thân chung chân răng: là phần thuộc chân răng của răng nhiều chân, từ đường cổ răng đến chẽ hai hoặc chẽ ba (hình 1-14).



Hình 1-14. Răng cối lớn 1 (hàm trên bên phải) nhìn từ phía ngoài.

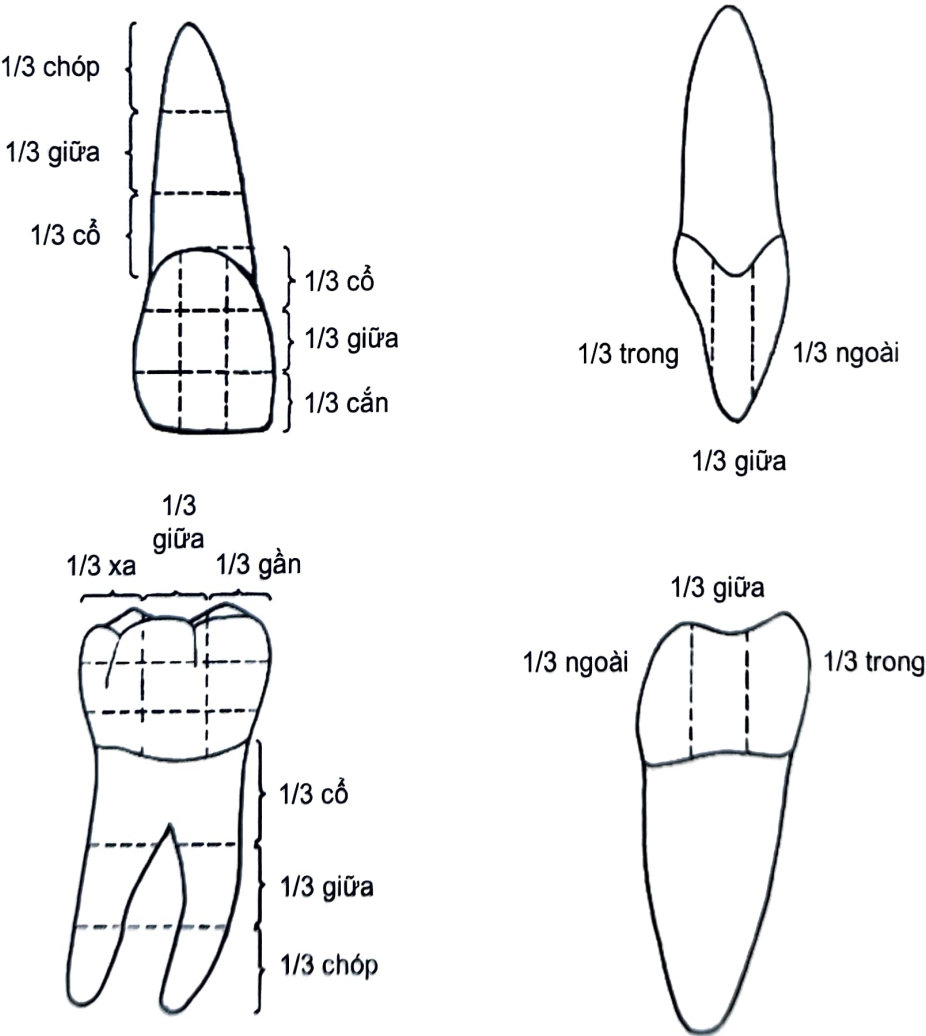
2.2.2. Chê hai, kê ba: là nơi thân chung chân răng phân chia thành hai hoặc ba chân riêng rẽ.

2.2.3. Vùng kê (vùng kê hai, vùng kê ba): là vùng thuộc nha chu, nơi mô nha chu có liên hệ đến kê hai, kê ba của chân răng.

2.2.4. Chóp chân răng: là đầu tận cùng hay đỉnh của một chân răng, còn gọi là “cuống răng”.

2.3. Các phần ba

Là sự phân chia tương ứng ở thân răng hoặc chân răng trên một mặt nào đó theo chiều nhai nướu (phần ba nhai, phần ba giữa, phần ba nướu hay phần ba cổ), theo chiều gần xa (phần ba gần, phần ba giữa, phần ba xa) hoặc ngoài trong (phần ba ngoài, phần ba giữa, phần ba trong). Chân răng thường được chia thành phần ba cổ, phần ba giữa, phần ba chóp (hình 1-15).



Hình 1-15. Các phần ba ở thân răng và chân răng.